



3

55. ÅRGANG | 03 • 2018

ARTIKEL

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT  
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

# Indhold

Ensomhed hos børn og unge med autisme

Børn lærer og udvikler sig gennem hvordan deres deltagelse i forskellige praksissammenhænge spiller sammen

## **Inklusionens udfordring: Børn med usynlige handicap**

Psykologen som konsulent i fælles refleksionsrum med rådsøger  
– rettet mod udviklingspsykologisk praksisudvikling for børn i  
bekymringsområder

Interaktionsobservation som grundlag for intervention omkring  
førskelebarnt med synsnedsettelse

Forudsigelse af alvorlige afkodningsvanskeligheder i 2. klasse på basis  
af testresultater i 0. og 1. klasse

Professionel kompetenceudvikling og social ulighed i dagtilbud

# Inklusionens udfordring: Børn med usynlige handicap



*Denne artikel tager fat i de usynlige sider af et handicap, med cerebral parese som gennemgående eksempel. I et individuelt og biologiske perspektiv består det usynlige handicap af perceptuelle og kognitive vanskeligheder, modsat de fysiske, som er umiddelbart synlige. Ydermere er nogle typer af kognitive vanskeligheder særligt svære at få øje på. Det gælder bl.a. hurtig udtrætning. Vi tænker ikke normalt på træthed som en funktionsnedsættelse på linje med fx opmærksomhedsforstyrrelser. Ikke desto mindre er det en udbredt kognitive funktionsnedsættelse blandt alle med en hjerneskade. Udtrætning bliver et problem, fordi vores sociale sammenhænge forudsætter at man er i stand til at arbejde koncentreret i et vist tidsrum. Børn med hurtig udtrætning kan derfor opleve at de ikke orker at være med – fx i de sidste skoletimer. Over tid kan det sætte dem bagud i forhold til deres kammerater – og måske være årsag til at børn med handicap oftere får psykologiske problemer.*

*Af Louise Böttcher, lektor, Aarhus Universitet, DPU*

At have et handicap påvirker barnets og den unges liv, ikke bare her og nu, men i et udviklingsperspektiv ind i voksenalderen. Undersøgelser viser at mange grupper af børn og unge med forskellige typer af handicap før eller senere udvikler adfærd, der opfattes som problematisk af omgivelserne eller kommer til at befinde sig i situationer, der både af dem selv og andre opfattes som problemfyldte og vanskelige at håndtere. Et centralt spørgsmål er hvor vi mener problemet ligger. Placeringen af problemet får efterfølgende betydning, når vi skal finde løsninger; hvem kan gøre noget og hvordan? I forhold til børn med handicap, har holdningerne på området typisk delt sig i to lejre. I den første lejr – den såkaldt medicinske model – placeres problemet i barnet. Barnet har en eller flere funktionsnedsættelser, som bliver hovedårs-

sagen til problemerne. Fx at barnet har en opmærksomhedsforstyrrelse, som giver sig udslag i forstyrrende adfærd og vanskeligheder med at indgå fx i læringsaktiviteter, der kræver vedvarende opmærksomhed. Den anden lejr udgøres af den sociale model. I dens forståelse er vanskelighederne et resultat af sociale barrierer. Hvis de sociale rammer var organiseret tilstrækkeligt inkluderende, ville barnets handicap blot være biologisk variation svarende til variationer mellem mennesker i øvrigt.

Denne artikel vil handle om hvordan det er muligt at kombinere de to umiddelbart ret modsatrettede måder at betragte problemerne på. Formålet med at formulere en kombineret forståelse er at bane vej for flere handlemuligheder for forældre, lærere og pædagoger i forhold til at skabe gode udviklingsbe-

tingelser for børn og unge med handicap.

## Hvad viser forskningen om problemet?

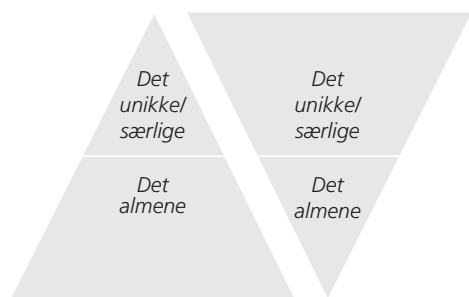
Børn med cerebral parese (spastisk lammelse) vil blive brugt som gennemgående eksempel. Der er flere grunde til at børn med cerebral parese (CP) er velegnet som eksempel på problemstillinger forbundet med at udvikle sig og lære, når man har et handicap. For det første er CP det mest udbredte fysiske handicap blandt børn. For det andet har størstedelen af børn med CP også et kognitivt, dvs. et ikke-synligt handicap. Mange af overvejelserne og pointerne omkring at støtte udvikling og læring hos børn med CP vil derfor også kunne overføres til børn med andre typer af usynlige handicap, fx børn med opmærksomhedsforstyrrelser eller børn med høretab. For det tredje bliver børn med CP i let eller moderat grad i stigende omfang inkluderet i almindelige klasser, hvorfor de fungerer fint som eksempel på de problematikker, der opstår når børn med anderledes biologiske forudsætninger skal fungere i en sammenhæng, der på mange måder er indrettet til børn, der fungerer mere typisk; 'som børn er flest'.

Børn med handicap er først og fremmest børn som alle andre – og deres udvikling vil i udgangspunktet have samme temaer som udvikling hos børn uden handicap: tilknytning, leg, udvikling af sociale relationer osv. Men psykologiske og sociale problemer er hyppigere i gruppen af børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Som gruppe har de flere konflikter med deres jævnaldrende,

færre venner, ses sjældnere med kammerater i fritiden og bliver oftere mobbet (Yude et al., 1998). Endvidere peger internationale undersøgelser på at adfærdsforstyrrelser og følelsesmæssige problemer er mere udbredte blandt børn med forskellige typer af handicap (Bjorgaas et al., 2012). Nogle af disse problemstillinger mærkes først og fremmest af barnet selv, fx problematikker omkring angst, mens andre i højere grad opleves af forældrene og omgivelserne i det hele taget, fx adfærdsvanskeligheder. Det kan være sociale problemer, angst, nedtrykthed, ensomhed, adfærdsproblemer og indlæringsvanskeligheder. Forskningen tyder endvidere på at børnene ikke vokser sig fra problemerne. Det gælder fx longitudinale undersøgelser, hvor man laver psykologiske vurderinger af den samme børnegruppe med fire års mellemrum og hvor man fandt at de børn, som havde haft psykologiske eller psykiatriske problemer i den første undersøgelse stadig havde dem i den anden, opfølgende (Goodman, 1998). Endvidere viser undersøgelser af voksne med funktionsnedsættelser også en forhøjet andel med problemer både socialt, følelsesmæssigt og erhvervsmæssigt (Damgaard et al., 2013). Samlet set kan selv en mindre funktionsnedsættelse over tid blive belastende i forhold til barnets muligheder for at udvikle sig socialt alderssvarende – også ud over hvad man kunne forvente ud fra funktionsnedsættelsen i sig selv.

Børn med handicap kommer oftere i kontakt med undersøgelses- og behandlingssystemet end typiske børn. Der er aspekter ved deres måde at fungere på, som vi har brug for at få be-

skrevet, så vi bedre kan forstå dem og finde ud af hvordan opståede problemer skal håndteres. Det er også alle disse særlige aspekter, som kan opleves som en udfordring i mange af de sociale sammenhænge, hvor barnet færdes og hvor dets udvikling og læring finder sted. Den nedenstående model opsummerer udfordringen:



Alle børn i en social gruppe, fx en skoleklasse, er naturligvis unikke. De kommer med hver deres erfaringer, måder at være på og interesser. Men samtidig vil de også have meget til fælles. De kan have erfaringer til fælles fra andre sammenhænge, de er vokset op i den samme tid og den samme kultur, hvor de har stiftet bekendtskab med mange af de samme bøger, film, spil, lege. De kan det samme sprog. De har måske gået til svømning sammen, har lært at cykle på omtrent samme tid. Deres fælles erfaringer og langt hen ad vejen parallelle udvikling gør at de har rigtig meget til fælles og kan indgå i de samme aktiviteter, fx i undervisningen, trods deres indbyrdes forskelligheder.

Så er det anderledes med barnet med et handicap. Uanset handicappet er det ofte svært umiddelbart at inkludere det barn i alle de samme aktivite-

ter, som de andre børn indgår i. I hvert fald uden at der foretages tilpasninger til de særlige behov barnet har i forhold til de perceptuelle, motoriske og kognitive funktioner. Så selv om barnet med et handicap har fællestræk med børn uden handicap, så kommer det unikke og særlige ved barnet til at fylde mere, når barnet skal indgå i sociale sammenhænge. Det er inkluderings udfordring. Og det er det forhold, som er med til at skabe de problemer, som psykologer kan blive sat til at finde løsninger til.

### Det usynlige handicap

Det særlige og unikke kan være mange forskellige ting afhængig af handicapet. Børn med cerebral parese har per definition et fysisk handicap, som kan variere fra barn til barn i sværhedsgrad og i hvilket omfang det fx involverer den ene side eller begge sider af kroppen og om det hovedsageligt er benene, armene eller begge dele, som barnet har svært ved at kontrollere. Afhængig af det fysiske handicap vil barnet have brug for tilpasninger af omgivelserne for at komme rundt (fx automatisk døråbning, ramper, trappe-lift) og hjælpemidler som rollator eller kørestol. Men ofte har børn med cerebral parese også en usynlig side af deres handicap. Det motoriske handicap skyldes en tidlig hjerneskade og den sidder ofte så den involverer ikke bare de motoriske områder eller ledningsbaner, men også andre områder kortikalt eller subkortikalt. Den usynlige side af handicappet kan derfor indbefatte perceptuelle, kognitive, adfærdsmæssige og/eller kommunikative vanskeligheder (Bottcher, 2010). Og trods det at de

er usynlige, beskrives de kognitive funktionsnedsættelser ofte som langt mere indgribende i den personlige handleevne end det synlige motoriske handicap. Eksempler på usynlige handicap kan fx være visuo-spatiale funktionsnedsættelser, som gør det svært at danne mentale kort fx af sine omgivelser, finde et sted hen og finde tilbage igen. Visuo-spatiale funktionsnedsættelser kan give problemer fx i matematik. Men det kan også gøre det svært at finde rundt på en skole.

Den første udfordring med det usynlige handicap er at det bliver overset. Det er der mange forskellige grunde til. For det første er fx perceptuelle eller kognitive funktionsnedsættelser i deres natur lettere at overse, fordi de ikke er direkte synlige. For det andet har der inden for behandlingen af børn med cerebral parese historisk været en trend hvor det synlige, motorisk handicap var i fokus, mens de ikke-synlige kognitive sider af handicappet enten blev tilskrevet mindre vægt eller var helt ukendte som del af handicappet. Denne historiske trend har det efterslæb at selv om kognitive, perceptuelle mv. usynlige sider af handicappet nu er inkluderet i definitionen, så er den samfundsmæssigt institutionaliserede behandling ikke fulgt med. Børn med cerebral parese får tilbudt vederlagsfri fysioterapi, mens en kognitiv undersøgelse hos en psykolog ikke indgår i tilbuddet. Så ud over at det usynlige, fx kognitive, handicap er sværere at se i sig selv, så er der også mindre opmærksomhed på at det findes og skal tages hånd om. Barnets forældre, pædagoger og lærere iagttager godt at barnet til tider opfører sig på måder,

der ikke svarer til de andre børns måde at opføre sig på, men de er ofte i tvivl om hvordan de skal forstå barnets handlinger. I et forskningsprojekt af børn med cerebral parese inkluderet i almindelige klasser i Danmark blev det netop klart, hvordan en psykologisk undersøgelse kan ændre forståelsen af barnet og dets støttebehov på en ny måde (Böttcher et al., 2014). Undersøgelsen og processen omkring den psykologiske undersøgelse kan give såvel forældre som lærere nye ord til at forstå og beskrive barnet og bidrage til at etablere en fælles reference for forældrene med barnets nærmeste lærings- og udviklingspartnere, som også inddrager de usynlige sider af handicappet.

En tredje udfordring omkring usynlige handicap er at mange børn og unge vælger at skjule dem i større eller mindre omfang. Det fysiske handicap kan være svært helt at skjule, men det usynlige handicap kan langt hen ad vejen godt holdes hemmeligt.

## **Den anden type af usynligt handicap**

I det foregående afsnit tog jeg udgangspunkt i et skel mellem de synlige og de usynlige sider af handicappet. Men selv inden for gruppen af usynlige handicap kan der skelnes mellem aspekter, der forholdsvis let kan afdekkes med en psykologisk undersøgelse og andre, som det er sværere både at opdage og efterfølgende at forstå behovet for tiltag i forhold til. Nogle typer af kognitive funktionsnedsættelser er lettere at forholde sig til som handicap end andre. Det er nemmere at forstå hvordan de begrænser barnet

og hvordan man derfor skal tage hånd om dem. Et eksempel kan være hukommelse. De fleste forstår hukommelse som begreb og alle har prøvet ikke at kunne huske et eller andet og hvordan det kan bremse én i det man er i færd med, hvis man ikke kan huske fx hvad man skulle hente eller købe. At blive opmærksom på noget, eller omvendt at blive afledt af noget forstyrrende, er også en kognitiv funktion og funktionsforstyrrelse, de fleste umiddelbart kan forholde sig til. Endvidere er opmærksomhedsforstyrrelser i og med udbredelsen af ADHD diagnosen blevet noget, mange skoler og lærere har fået erfaring med at håndtere pædagogisk. Men gruppen af børn med cerebral parese kan også have kognitive funktionsnedsættelser, som ikke indgår på listen over klassiske kognitive funktioner, men ikke desto mindre udgør en central del af deres usynlige, kognitive handicap. Det gælder hurtig udtrætning, langsommere informationsbearbejdning og varierende præstationsniveau. Samtidig er det værd at nævne at de tre kognitive funktionsnedsættelser langt fra er begrænset til børn med cerebral parese, men også kan være et problem hos fx for tidligt fødte børn og børn med erhvervet hjerneskade. Jeg vil i det følgende beskrive de tre lidt nærmere, da de vil gå igen senere i kapitlet som eksempler.

*Hurtig udtrætning* handler om at mange børn med cerebral parese bliver mentalt trætte hurtigere end børn i almindelighed og at deres præstationsniveau – når de er blevet trætte – kan falde rigtig meget. Så meget at det kan være svært at deltage i aktiviteter, fx følge med i de sidste timer i skolen

eller have overskud til de spændende aktiviteter i skolefritidsordningen. Det kan kræve meget tydelig formidling til forældre og lærere at der er tale om noget andet end almindelig træthed.

*Varierende præstationsniveau* kan ses i sammenhæng med den hurtige udtrætning. Hen over dagen kan det variere meget, hvad barnet kan. Et helt konkret eksempel er Marcus, som havde nedsat synsskarphed. Han havde brug for at teksten blev forstørret for at han kunne læse den. Men størrelsen på bogstaverne var ikke fast, men varierede efter hvor træt han var. En mere krævende dag kunne betyde at han sidst på dagen havde brug for at have bogstaverne på skærmen større end tidligere på dagen.

*Langsommere informationsbearbejdning* udspringer af at den underliggende hjerneskade ved cerebral parese meget ofte involverer områderne under korteks, den hvide substans. Den hvide substans indeholder mange informationsbaner både fra de subkortikale kerner og ud til korteks og informationsbaner mellem forskellige områder i korteks. Alt efter placeringen af hjerneskaden vil skaderne på den hvide substans påvirke informationsstrømmen rundt i hjernen og en af effekterne er at informationen løber langsommere. Det kan være ganske diskret eller det kan være barnet med tydelig latenstid. Ligesom med det fysiske handicap er der mange forskellige grader af nedsat hastighed i informationsbearbejdningen.

En anden grund til at disse tre kognitive funktionsnedsættelser kan risikere at blive overset, er at de ikke kan undersøges med specifikke prøver i en psykologisk undersøgelse, men i stedet

viser sig kvalitativt i barnets præstationer, på tværs af forskellige opgavetyper både i den psykologiske undersøgelse og i daglige undervisningsaktiviteter. Barnet har ikke svært ved én bestemt type opgaver. I hverdagen kan vanskelighederne fx komme til udtryk ved at barnet ofte ikke når at blive færdig med en opgave i det tidsrum de andre børn når at blive færdige på. Eller barnet kan ikke det samme sidst på dagen som i starten. I den psykologiske undersøgelse kan vanskelighederne fx vise sig ved at barnet er langsommere om mange forskellige opgaver eller ikke kan testes lige så længe som andre børn, hvorfor testningen fx må deles i to eller tre gange.

Samlet set er der således flere aspekter, som bidrager til at et handicap, eller dele af et handicap, bliver usynligt. Men fælles for de ovenstående aspekter er at de alle placerer handicappet i barnet, som et aspekt ved barnet. I forhold til børn med cerebral parese kan vi fx sige at de usynlige aspekter udspringer af barnets hjerne-skade. Den tilgang vil jeg gerne overskride i de kommende afsnit.

## Handicappets sammenhæng med kulturelle krav og betingelser

Hverken den kognitive udvikling eller barnets udvikling i øvrigt foregår isoleret fra omgivelserne. Tværtimod er børns udvikling et livsforløb gennem vuggestue, børnehave og skole, hvor kravene til barnet øges både kvalitativt og kvantitativt i takt med barnets kronologiske alder. Vores forventninger til, hvad et barn kan eller bør kunne klare, tager typisk udgangspunkt i barnets alder. Barnets biologiske ud-

vikling er så at sige indlejret i aldersrelaterede sociale og kulturelle krav. Eksempelvis er den daglige praksis i en vuggestue tilrettelagt i forhold til en forventning om at børnene skal have hjælp til mange praktiske ting så som at bevæge sig rundt, spise og tage tøj af og på. Ved overgangen til børnehave i treårs-alderen er forventningerne til gengæld at børnene kan netop disse ting eller i hvert fald er godt på vej til at mestre dem.

Forholdet mellem barnets udviklingsmæssige parathed og forventninger og krav fra den praksis, børnene indgår i, gælder også i forhold til barnets kognitive udvikling. Børn i folkeskolens mindste klasser får små, basale opgaver at arbejde med. Større projekter styres af læreren og deles ind i mindre bidder og konkrete opgaver. Senere i skoleforløbet ændres kravene og i de ældste klasser er praksis i højere grad organiseret ud fra at børnene begynder at kunne arbejde selvstændigt med større projekter over længere perioder. Udviklingen fx i kognitiv funktion sker ved at barnet deltager i aktiviteter, hvor det lærer at forstå og håndtere kulturelle redskaber og symboler. For at tage et eksempel:



Vores biologisk givne perceptuelle system kan umiddelbart analysere at den øverste figur består af to skrå streger og en lige streg, som tilsammen danner en sammenhængende figur. Der er dog ingen af denne artikels læ-

sere som ser figuren som 'to skrå streger og en lige streg'. Vi ser den umiddelbart som bogstavet A. Vores deltagelse i undervisningsaktiviteter tilrettelagt på at lære os at læse – og i øvrigt en række andre aktiviteter hvor børn introduceres til alfabetet – har forandret vores perception, således at vi perciperer figuren som et A uden at skulle tænke bevidst over det. Vores perception 'kulturaliseres'. Vygotsky begrebsatte det med at vores mentale funktioner udvikler sig fra basale til højere mentale funktioner (Vygotsky & Luria, 1994). Andre eksempler på forandringen fra basale til højere mentale funktioner er hvordan sproglige begreber og den viden de repræsenterer gør os i stand til at se en lighed mellem fx et birketræ og en fyrretræ; det er begge træer, skønt de perceptuelt ser forskellige ud.

Udviklingen fra basale til højere mentale funktioner forudsætter dog at vi deltager i de sociale sammenhænge, hvor de kulturelle redskaber introduceres og anvendes. Deltagelsesbetingelserne i den sociale sammenhæng må være udformet, så de deltagende børn har en mulighed for at være med. Børns udviklingsforløb formes gennem det komplekse samspil mellem den biologiske udvikling og krav og aktiviteter i sociale sammenhænge. Hverken krav eller overensstemmelse er naturgivne. I stedet er de resultatet af en gensidig kultur-historisk udviklingsproces mellem børnene og de praksisser, som børnenes liv og udvikling foregår i. Skolen og undervisningens indhold ændres løbende, både i forhold til politiske beslutninger, forskning om hvordan børn lærer bedst og i forhold til de børn, som

skal gå i skole. Praksis i skolen er tilrettelagt, så der er en nogenlunde overensstemmelse mellem de krav barnet møder og barnets mulighed for at lære at leve op til kravene. Overensstemmelsen behøver ikke være fuldstændig, men bare tilstrækkelig til at kravene er *relevante* for de børn, der skal indgå i den sociale sammenhæng.

Overensstemmelsen mellem barnet og omgivelserne bliver dog ofte udfordret, når det gælder børn med funktionsnedsættelser. Den sociale praksis; undervisning, fritidsaktiviteter, undervisningsmaterialer m.v. er i virkeligheden tilrettelagt ud fra en række antagelser om deltagernes forudsætninger. Det kan være forholdsvis let at få øje på i det fysiske miljø. En trappe forudsætter at aktørerne kan gå på deres ben og kan holde balancen på turen op. Et klatrestativ forudsætter en vis styrke og kontrol over arme og ben. Men aktiviteter har mange flere indbyggede forudsætninger til fx motoriske, perceptuelle og kognitive funktioner. I en almindelig undervisningssammenhæng uden nogen tilpasninger forudsættes det at eleven kan sidde på en almindelig stol uden at skulle bruge særlig energi på den proces, kan rette sin opmærksomhed mod læreren, når denne forklarer noget, kan høre lærerens forklaring, kan se hvad læreren fx viser på tavlen, kan huske lærerens forklaringer senere, kan arbejde i et givet tidsrum og hen over en skoledag af en vis længde, kan finde de rigtige bøger... Der kan med lethed laves en meget længere liste over de indbyggede forudsætninger til kognitive funktioner i en skoledag. En liste, som børn med mange forskellige handicap har svært

ved at lave op til. Og mens konsekvenserne af fx et høretab er forholdsvis indlysende i forhold til behovet for tilpasning af den sociale ramme (også selvom praksis efterfølgende ikke altid fungerer uproblematisk), så er det sværere at få øje på følgerne af hurtig udtrætning og langsom informationsbearbejdning. Men på samme måde som at undervisningen almindeligvis er bygget op omkring en forudsætning om at eleverne kan høre hvad læreren og hinanden siger, så er undervisningen også bygget op omkring en række antagelser om hvor længe elever er i stand til at arbejde og i hvilket tempo undervisningsaktiviteter kan afvikles. Et eksempel kan gøre det mere konkret, hvordan langsom informationsbearbejdning kan blive et problem i en undervisningsmæssig sammenhæng.

*Caseeksempel: Michael (På basis af interview med 'Michaels' mor og psykolograpporter)*

*Michael er en dreng på 9 år, som går i 2. klasse på en almindelig folkeskole. Michael blev født til tiden, men fik kramper og unormale reflekser i timerne efter fødslen. Mistanken om hjerne-skade blev bekræftet af en MR skanning. Michael har cerebral parese, men med kun få og meget lette fysiske symptomer. Derimod har han kognitive funktionsnedsættelser, som hen ad vejen viser sig at skabe problemer i de undervisningssammenhænge, hvor det er meningen Michael skal deltage.*

*De vanskeligheder, der først blev tydelige, var Michaels vanskeligheder med at udtrykke sig. Han havde ofte svært ved at finde ordene, var meget*

*lang tid om at svare, hans svar kunne være uforståelige og han foretrak ofte at svare nonverbalt i stedet for at udtrykke sig med ord. I børnehavetiden var han også meget tilbageholdende og passiv i forhold til de andre børn, men kunne godt indgå i rolle- og fantasilege, når han blev inviteret med af de andre børn. På grund af de kommunikative og sociale vanskeligheder begyndte han i en taleklasse, som kommunen havde som tilbud i 0. klasse. I taleklassen fungerede Michael fint. Det var en mindre klasse og de andre børn havde også brug for tid og støtte til at udtrykke sig.*

*Taleklassen var dog kun et indslusningstilbud, så fra første klasse skulle Michael til at gå i en almindelig klasse med 28 børn. Klassens øvrige elever var meget aktive og snakkende. Det var ofte svært for Michael at komme til orde i undervisningen. Han havde også svært ved at følge med i tempoet i undervisningen, enten fordi han ikke kunne nå at fange lærerens spørgsmål, før de andre i klassen allerede var klar til at svare eller ved at blive så presset af tempoet, at han ikke kunne formulere sit svar, men gik i stå eller talte sort. I løbet af 1. og 2. skoleår kom Michael derfor bagud med at lære at læse, i slutningen af 2. klasse kunne han endnu ikke alfabetet og havde også problemer i forhold til at få mening i selv korte, enkle sætninger (fx ved oplæsning).*

*På grund af de sproglige og skolefaglige vanskeligheder var Michael blevet undersøgt med psykologiske test både inden skolestart og i løbet af 1. klasse. Begge test viste en dreng med begavelse i normalområdet, men med særlige vanskeligheder inden for ekspressivt sprog (evnen til at udtrykke sig), van-*

*skeligheder med at afkode visuelt materiale, vanskeligheder med selv at skabe overblik og struktur og med at huske og genkalde sprogligt materiale. Særlig den anden psykologiske rapport beskrev at Micheal havde et meget svigende præstationsniveau, således at han havde vekslende opmærksomhedsvanskeligheder, at hans sproglige formåen var meget svingende og at han nogle gange havde en meget lang svartid. Svingningerne blev tolket til at hænge sammen med at Micheal hurtigt blev træt, når han skulle koncentrere sig i længere tid ad gangen. En anden konklusion i rapporten var at Michael klarede sig væsentligt bedre i testningssituationen end i klassen. Endvidere bekræftede en klasseobservation at særlig problemerne med at udtrykke sig mundtligt blev mere udprægede i mange af klassens fællesaktiviteter, hvor der var meget støj, uro og et ret højt kommunikativt tempo.*

Eksemplet viser, hvordan deltagelsesforudsætningerne hos et barn med en funktionsnedsættelse og omgivelsernes rammer i form af sociale og kulturelle praksisser står i et indbyrdes misforhold. De rammer, der understøtter udvikling og social deltagelse for typisk udviklende børn, gør det ikke i samme grad når barnet har et handicap. Det er dette misforhold, som skaber handicappet. Overensstemmelsen mellem barn og omgivelser, det vi oplever som 'den automatiske'/indbyggede udviklingsstøtte, er faktisk et socialt og kulturelt produkt. Vi understøtter udvikling og læring gennem sociale aktiviteter, som barnet deltager i. Uoverens-

stemmelsen mellem barnet med handicap og omgivelserne betyder at social deltagelse, læring og udvikling skal finde sted på vanskeligere betingelser. Rammerne for læring og udvikling er ude af trit med barnets behov.

### **Problemet med at følge socialt institutionaliserede udviklingsforløb**

En del børn og unge med funktionsnedsættelser er eller bliver forsinkede i deres udvikling, set i forhold til jævnaldrende uden handicap. Forsinkelsen kan være afledt af biologiske forhold, fx kan barnet have et genetisk betinget syndrom, som blandt andet påvirker hastigheden af de biologiske modningsprocesser. Men den udviklingsmæssige forsinkelse kan også skyldes at barnets funktionsnedsættelser begrænser dets mulighed for at interagere med sine forældre, afprøve sin krop eller lege med andre børn. De fleste funktionsnedsættelser, i hvert fald når de er af moderat eller svær grad eller optræder flere sammen, vil påvirke barnets mulighed for at deltage i gængse aktiviteter sammen med voksne eller med andre, jævnaldrende børn. Det er sværere og tager længere tid at udforske verden, hvis man ikke kan bevæge sig rundt selv på grund af motorisk handicap eller hvis ens adgang til at opfatte verden er mindre på grund af sansehandicap eller perceptionsforstyrrelser. Man kan sige at de normale udviklingsprocesser tager længere tid og derfor vil børn med moderate og svære funktionsnedsættelser typisk være forsinkede i deres udvikling sammenlig-

net med jævnaldrende uden funktionsnedsættelser.

I et individuelt perspektiv har det ikke så stor betydning om barnet lærer en færdighed tidligere eller senere, så længe færdigheden opnås. Men som tydeliggjort i eksemplet med Michael ovenfor, foregår udvikling i samspil med andre børn og med sociale krav og betingelser, der i høj grad er organiserede ud fra aldersrelaterede forventninger. Barnets udviklingsmæssige forsinkelse kommer derved i spil med dets sociale andre. Udvikling er ikke kun et spørgsmål om den løbende biologiske modning, men også om tilstedeværelsen af sociale udviklingsmuligheder og muligheden for at udnytte dem. De kultur-historiske sociale udviklingsbetingelser forstået som organisationer af aktiviteter og udviklingsstøtte er udfoldede i tid som institutionelle udviklingsbaner, barnet deltager i, med udgangspunkt i dets kronologiske alder. Værdier om passende færdigheder og måder at deltage på er indbygget i barnets udviklingsarenaer sammen med de former for udviklingsmæssig støtte, der anses for relevante af deltagere som pædagoger, lærere, forældre m.v. Over tid forandrer kravene og støtten sig, således at færdigheder der støttes i en periode, forudsættes i den næste.

I neurobiologisk forstand taler man om kritiske perioder, forstået som et biologisk mulighedsrum hvor en bestemt type udvikling skal finde sted (Greenough et al., 1987). Ved slutningen af den kritiske periode forsvinder de biologiske muligheder og senere udvikling af funktionen vil være på et ringere niveau eller slet ikke muligt.

Denne type biologisk kritisk periode findes fx inden for de primære visuelle og auditive områder, som skal modtage hhv. visuel og auditiv stimulation tidligt i individets udvikling for at udvikle sig normalt. Dette begreb om kritiske perioder kan overføres til andre aspekter af barnets udvikling. På bestemte, afgrænsede tidspunkter i den sociale og kognitive udvikling opstår der perioder, hvor særlige typer af udvikling er understøttet, ikke af neuroner, men af sociale udviklingsmuligheder. I det to-årige barns liv er der som oftest rige muligheder for at lege fysiske lege og tumlelege, mens læseindlæringsaktiviteter er få eller fraværende. Men hen over børnehavealderen og i de første indskolingsår vil barnets dagligdag rumme talrige aktiviteter, hvor bogstavers udseende og lyde indgår, fra aktiviteter med rim og remser, til fælles læsning i klassen, små bøger med korte sætninger og billeder til at ledsage teksten og lette afkodningen af ordenes betydning. En social kritisk periode for læsning er opstået som en mulighedsrelation mellem barnet og omgivelserne.

Tilstedeværelsen af aktiviteterne i den sociale praksis alene bevirker selvfølgelig ikke at barnet lærer fx at læse. Det er en anden, lige så nødvendig forudsætning, at barnet psykologisk er parat. I indskolingen taler vi om skoleparathed, at børnene er interesseret i skolens aktiviteter og formålet med dem, fx gerne vil være at læse. Det er en indbygget forudsætning, ligesom de forskellige indbyggede krav til perceptuel og kognitiv funktion. Også her kan børn med handicap afvige, fordi de på grund af langsommere udvikling end-

nu ikke har udviklet et læringsmotiv og derved ikke er 'skoleparate' på samme måde som deres typisk udviklende kammerater.

Den sociale kritiske periode fortsætter i de første indskolingsår, hvorefter mulighedsrelationen 'læseindlæring' bliver afløst af andre aktiviteter ud fra en forventning om at børnene har lært at læse. Hvis et barn stadig ikke har lært at læse, bliver det svært for ham eller hende at indgå i undervisningsaktiviteterne. Og læseindlæringen er ikke længere understøttet i den almindelige praksis.

Modsat biologiske kritiske perioder er sociale kritiske perioder ikke forbundet med uigenkaldelig tabte udviklingsmuligheder. Men det kan blive nødvendigt at skabe en alternativ social praksis for læseindlæring ved siden af hovedstrømmen af undervisning, en alternativ aktivitet, som kan støtte læseindlæringen hos børn, der har vanskeligheder med at lære at læse. Det tidlige aspekt af handicapet opstår derfor fordi socialt samvær og læringsaktiviteter er organiserede i institutionaliserede tidsforløb. Handicappet kan forandre sig over tid i forhold til hvordan barnet kan eller ikke kan følge de institutionelle udviklingsbaner og udnytte sociale kritiske udviklingsperioder. Den ramme, Michael er i i sin skole, støtter ikke hans udvikling af kommunikation og social deltagelse. Tværtimod er den med til at fastholde og forstørre hans kommunikative vanskeligheder og gøre det svære for ham at udtrykke sig om sine tanker og behov og i det hele taget byde ind i klassens sociale fællesskab. Michaels vanskeligheder med at nå at

forstå det faglige indhold og med at bidrage aktivt i undervisningen – højt tempo, udtrætning, situationer hvor han bryder sammen og opgiver at deltage – betyder at spændet mellem hvad han kan fagligt set og hvad de andre børn kan vokser over tid. Hvis Michael forsat skal forsøge at følge klassens faglige niveau, vil misforholdet mellem hans individuelle formåen og de sociale krav med stor sandsynlighed vokse. Selvfølgelig har hans individuelle måde at fungere på betydning. Men en stor del af problemerne – i form af manglende fremskridt inden for læsning, kommunikative problemer, social eksklusion, psykiske problemer – er udviklet ud fra det misforhold der er mellem Michaels egen formåen og de rammer og betingelser, han skal fungere i i sin hverdag.

Det er nu på tide at vende tilbage til inklusionens udfordring, som den blev skitseret indledende i artiklen. Her blev udfordringen beskrevet som det forhold at mens typisk udviklende børn har meget tilfælles, har børn med handicap en række særlige behov, som gør at de ikke umiddelbart kan passe ind i de samme aktiviteter, som de andre børn deltager i. Det særlige og unikke fylder mere hos dem. Siden har artiklen handlet om hvordan fremkomsten af både det almene og det særlige ikke er naturgivent, men opstår i samspillet med omgivelserne. Dette skift i forståelse ændrer i første omgang ikke ved forholdet at der er noget anderledes ved børn med handicap i den sociale sammenhæng. Men skiftet i placering af problemet – fra et individuelt til et socialt perspektiv – har betyd-

ning for hvilke løsninger, det er muligt at få øje på.

## Håndtering af problemets mange lag

Børn med funktionsnedsættelser bliver ofte mødt – og den eventuelle støtte til inklusion organiseres ud fra – et individuelt perspektiv, som hviler på en antagelse om at den medfødte eller erhvervede funktionsnedsættelse er hovedårsagen til at barnet falder udenfor. I Michaels tilfælde blev han tildelt en støttepædagog.

*I løbet af 1. klasse bliver Michael i stigende grad følelsesmæssigt belastet af at klare hverdagens krav. Han forsøger så godt han kan, men bliver ofte opgivende, ked af det, græder. Støttepædagogen afhjælper kun problemet i de timer, hvor hun er til stede. I andre timer siger han ofte ingenting, har svært ved at følge med i aktiviteterne og kan bryde sammen i gråd, hvis der er for meget uro og forvirring omkring ham. I frikvarterne løber Michael i udkanten af de igangværende lege, men uden at være med i dem. Når pedellen arbejder i legeområderne, søger Michael at gå med som hans hjælper. Forældrene beskriver at Michael om morgen er trist, ofte grædende og uden lyst til at stå op. Efter skole er han udmattet og har ikke overskud til eventuelle lektier.*

Fra at fungere anderledes men som del af fællesskabet i børnehaven og i taleklassen, er Michaels situation forandret, således at han i stigende grad fremtræder anderledes og uden for fællesskabet. Problemet er velkendt – at børn fungerer relativt godt i de mindre

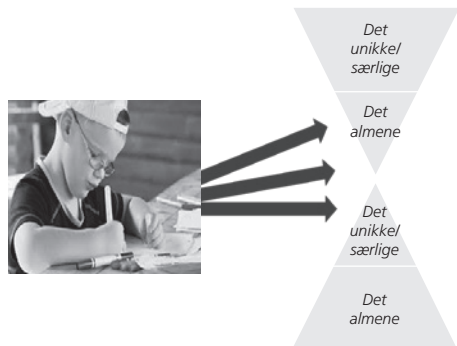
klasser, men får stigende problemer gennem mellemtrinnet og i udskolingen – og det italesættes ofte som at barnet 'vokser sig ind i problemerne'. En del af problemet for mange af børnene og de unge kan sagtens være at mellemtrinnet og udskolingen i stigende grad stiller krav til eksekutive funktioner (evnen til bl.a. målsætning og målstyring, initiativ, impulskontrol og følelsesmæssig regulering (Baron, 2004)) og hvis barnet eller den unge har vanskeligheder på netop dette område, kan det blive mere synligt i de større klasser. Men den problemanalyse fanger kun én del af problemet. Det andet er at barnets vanskeligheder med at deltage i den sociale sammenhæng kan få barnets særegenhed til at vokse.

For det første kan barnet udvikle psykologiske og psykiatriske vanskeligheder. Det var fx tilfældet med Michael fra casen, men han er langt fra alene. Forekomsten af psykologiske og psykiatriske vanskeligheder er høj blandt børn med handicap, væsentlig højere end hos gruppen af børn uden handicap (Dammeyer og Bøttcher, 2010).

For det andet bevirker vanskelighederne med at deltage aktivt i såvel undervisningsaktiviteterne som frikvarterne at barnet ikke lærer det samme som de andre børn. Michaels manglende fremskridt inden for læsning sætter ham i stigende grad bagud i forhold til klassekammeraterne. Det kan sagtens være at han allerede fra starten af havde brug for særlig støtte til læseindlæringens tidligste trin. Men problemet vokser over tid, når klassekammeraterne er kommet længere i læseprocessen og det både i dansk og andre fag forudsættes at man kan bogstaver-

ne og kan læse små, enkle tekster. Michaels hjerneskade, hans psykologiske problemer og deltagelsesproblemer skaber en situation, der kan betegnes som kulturel deprivation; At Michael ikke lærer de kulturelle begreber og redskaber, som ellers ville bidrage til hans læring og generelle udvikling gennem udvikling af højere mentale funktioner.

Det to forhold tilsammen; psykologiske og psykiatriske problemer og kulturel deprivation, skaber en sekundær udviklingsforsinkelse. I takt med at barnet kommer bagud i forhold til de andre børn i den sociale sammenhæng, vokser det særlige og unikke ved barnet. Forholdet mellem det almene og det unikke er derfor ikke givent, men et udviklingsmæssigt forhold:



I caseeksemplet forekom to af de helt centrale dele af den aktuelle problematik; social isolation og følelsesmæssig sårbarhed helt eller hovedsageligt afledt af Michaels hverdagssituation. Støttepædagogen fungerede som en reparerende mekanisme i forhold til misforholdet – men uden at fjerne det – og Michaels afhængighed af hende er en meget typisk afledt problematik. Til-

stedeværelsen af en støtteperson (til barnet frem for til klassen) indfører et lille fællesskab parallelt til klassen og skaber distance mellem barnet og klassens sociale fællesskab, ikke bare i timerne, men også i frikvarterne (Giangreco et al., 2010). Samtidig har en støtteperson som løsning den ulempe at der ikke ændres grundlæggende ved de indbyggede forudsætninger i omgivelserne, som har været med til at skabe problemet (Wendelborg & Tøssebro, 2010). Uoverensstemmelsen mellem tempoet i klasseaktiviteterne og Michaels behov for et lavere tempo blev fx ikke adresseret.

Inklusion kan være med til at skabe en meget krævende hverdag for børn med en funktionsnedsættelse, hvis de skal gøre det samme som andre børn – på de samme betingelser. Michaels placering i en normalklasse har været med til at forstørre hans handicap, og placere ham i en social position som en dreng, der ikke forstår hvad der foregår og kan bidrage til fællesskabet, er anderledes, er tavs eller taler volapyk, ofte bryder sammen og græder, er mest sammen med og mest søger de voksne. Sideløbende er de andre børn optaget af at udbygge venskaberne med hinanden. Der er således grund til at tro at den nuværende sociale ramme, over tid og med de nuværende krav og betingelser, vil forstærke Michaels handicap og særegenhed.

Omvendt betyder placeringen af problemet i spændet mellem barnets forudsætninger og krav og betingelser i den sociale praksis at de professionelle omkring barnet får flere handlemuligheder. Så længe problemet antages at være hjerneskaden i sig selv, kan vi

højest reparere på følgerne. Problemet i sig selv betragtes som uafvendelige følger af barnets særlige neurale forhold. Men når vi i stedet arbejder ud fra et fokus på uoverensstemmelsen mellem barnet og omgivelserne og begrebet om sociale kritiske perioder i institutionaliserede udviklingsforløb, peger det hen til andre interventionsfoci. Problemet kan ikke entydigt placeres ét sted. Tværtimod er det nødvendigt at adressere udfordringer på flere forskellige niveauer.

I forhold til handicappets individuelle, usynlige side er der brug for at de professionelle omkring barnet får viden om det specifikke handicap barnet har. Det er nødvendigt at stille spørgsmålet i hvilket omfang og hvordan de sociale barrierer har rod i den biologiske baserede funktionsnedsættelse, selvom de er opstået og udvikler sig i det dialektiske samspil med barnets omgivelser. Mange børn med cerebral parese er inkluderet i almindelige klasser, hvor de forventes at fungere på samme betingelser som de andre børn. Det er essentielt at få ord på problemet, at få etableret et fælles sprog som udgangspunkt for at analysere problemet og skabe et samarbejde fx forældre og lærere imellem om at løse det.

Handicappets kulturelle indlejring kræver at vi stiller spørgsmål både til os selv, de aktiviteter vi arrangerer for børn og til de fysiske omgivelser: Hvilke perceptuelle, kognitive, kommunikative og motoriske forudsætninger er indbygget i omgivelserne? Hvordan passer de til de børn, som skal deltage? Med udgangspunkt i psykologiske undersøgelser og observationer kan psy-

kologen i samarbejde med læreren se på hvilke tiltag der er brug for i forhold til at sikre barnets mulighed for at deltage i undervisningsaktiviteten.

Handicappets tidlige aspekt handler om at være på forkant med det konkrete barns udfordringer og behov for støtte. Uoverensstemmelsen mellem barn og omgivelser øges, hvis børn kommer mærkbart bagud i forhold til sociale milepæle, fx trinmål eller 'at knække læsekoden'.

Samlet set skal interventionen have to ben: For det første at sikre at barnet har relevante udviklingsbetingelser, som svarer til dets kognitive og sociale kapaciteter. Funktionsnedsættelser og sociale barrierer opleves konkret af børnene, deres familier og de professionelle omkring barnet og der er behov for at finde løsninger i de konkrete sammenhænge. Men vi skal samtidig holde fast i at opgaven ikke kun er at afhjælpe vanskelighederne her og nu, men helt grundlæggende består i at skabe udviklingsmuligheder for barnet med handicap. Udviklingsmål skal ikke kun være for barnets faglige udvikling, men også for barnets sociale udvikling, herunder sikre tilgængelighed af relevante kammerater, fx i samarbejde med barnet og dets forældre. Det dialektiske perspektiv på handicap bygger på en forståelse af udvikling som et dynamisk kædeforløb, hvor såvel kompetencer som vanskeligheder aldrig er statiske, men vedvarende påvirker barnets udvikling i en sociokulturel ramme. Hvis barnet på grund af sit handicap har været begrænset i sine muligheder for at deltage i aktiviteter fx i børnehavealderen, kan det meget vel være forsinket i udviklingen

af betydningsfulde kognitive og sociale, herunder kommunikative, kompetencer ved skolestart. De vanskeligheder, som mange børn med handicap oplever, kan derfor have forskellige forudgående udviklingsforløb, som kun delvist skyldes funktionsnedsættelsen. Endvidere vil barnets handlinger i hverdagen i en dialektisk optik betragtes som udtryk for barnets aktive forholden sig til og forsøg på at påvirke sine udviklingsbetingelser. Familiens og barnets aktive forholden sig til deres betingelser er en styrke, men kan samtidig være med til at placere dem i en udsat position. Michaels aktive handlinger, som beskrevet i casen, kan refortolkes som hans reaktioner på en for ham uholdbar social situation. På den ene side er handlingerne med til at placere ham i en sårbar position i og med han fx bryder grædende sammen i timerne. Men på den anden side skaber de et meget tydeligt signal til omgivelserne om at han ikke trives. Signalet er blevet opfanget af omgivelserne, først og fremmest af hans forældre, der har startet en aktiv kamp for at skaffe Michael et andet skoletilbud gennem kontakt til kommune, psykolog og besøg på andre skoler. Michaels problemer bliver på den måde også til forældrenes kamp for at skaffe ham bedre lærings- og udviklingsbetingelser.

Det andet ben er at forebygge belastningssymptomer. Belastningssymptomer, fx i form af social tilbagetrækning eller psykiatriske problemstillinger, kan være med til at skubbe barnet yderligere mod 'at være særlig' og have svært ved at deltage i undervisning og andre sociale sammenhænge. Opgaven

tilsammen bliver derved at tilrettelægge udviklingsmuligheder som et udviklingsforløb. Det vil sige at projicere barnets nuværende udviklingssituation ud i fremtiden:

- Hvilke mål er den nuværende støtte-/udviklingssituation rettet mod?
- Hvilke fremtidige mål åbner den nuværende situation op for, hvilke er på vej mod at blive mindre sandsynlige?
- Hvilke forandringer er der brug for i den nuværende støtte-/udviklingssituation i forhold til de mål, barnet/familien/de professionelle tilsammen ser som rigtige?

Her ved afslutningen af artiklen står det derfor klart hvorfor hverken den medicinske og den sociale model duer alene. De har begge fat i centrale dele af problemet, men mangler at integrere de to dele med hinanden og nå frem til en forståelse af hvordan problemerne ved at være barn med handicap er dybt forankret i såvel barnets biologiske forudsætninger som i de implicitte kulturelle forudsætninger for deltagelse i alle sociale sammenhænge.

## Referencer

- Baron, I S. (2004). *Neuropsychological evaluation of the child*. Oxford: Oxford University press.
- Bjorgaas, H., Hysing, M. & Elgen, I. (2012). Psychiatric disorders among children with cerebral palsy at school starting age. *Research in Developmental Disabilities*, 33, 1287-1293.
- Böttcher, L. (2010). Children with spastic cerebral palsy, their cognitive functioning and social participation. A review. *Child Neuropsychology*, 16, 209-228.
- Böttcher, L. (2008). Neurobiological constraints. A role for neuropsychology in the

- cultural-historical activity approach to understanding the cognitive development and learning of children with cerebral palsy. PhD afhandling, Københavns Universitet.
- Böttcher, L., Falkenstrøm, B., Nielsen, L. B. (2014). Kognitive undersøgelser af børn med cerebral parese som grundlag for inkludering i skolealderen. *Pædagogisk psykologisk tidsskrift*, 51(5/6), 91-104.
- Damgaard, M., Steffensen, T. & Bergtsson, S. (2013). *Hverdagsliv og levevilkår for mennesker med en funktionsnedsættelse. En analyse af sammenhænge mellem hverdagsliv, samliv, udsathed og type og grad af funktionsnedsættelse. København: SFI.*
- Dammeyer, J & Böttcher, L. (2010). Handicap som risikofaktor. Et udviklingspsykopatologisk perspektiv på børn med handicap. *Psyke & Logos*, 21(2), 668-687
- Giangreco, M. F., Suter, J. C., Doyle, M. B. (2010). Paraprofessionals in inclusive schools: A review of recent research. *Journal of educational and psychological consultation*, 20, 41-57.
- Goodman, R. (1998). The longitudinal stability of psychiatric problems in children with hemiplegia. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 39, 347-354.
- Greenough, W. T., Black, J. E., Wallance, C. S. (1987). Experience and brain development. *Child Development*, 58, 539-559.
- Rogoff, B. (2003). *The cultural nature of human development*. Oxford: Oxford University press.
- Vygotsky, L & Luria, A. (1994). Tool and symbol in child development. I: R. van der Veer & J. Valsiner (eds): *The Vygotsky reader*, s. 97-174. Oxford: Blackwell.
- Wendelborg, C. & Tøssebro, J. (2010). Marginalisation processes in inclusive education in Norway: a longitudinal study of classroom participation. *Disability & society*, 25(6), 701-714.
- Yude, C., Goodman, R. & McConachie, H. (1998). Peer problems of children with hemiplegia in mainstream primary schools. *Journal of child psychology and psychiatry*, 39(4), 533-541.